

La cystoscopie permet à votre chirurgien d'examiner l'intérieur de votre urètre et de votre vessie à l'aide d'un fin tube optique muni d'une caméra et d'une lumière, introduit doucement par l'orifice urinaire naturel. Elle aide à trouver la cause du sang dans les urines, d'infections, de rétrécissements ou d'autres problèmes vésicaux — et à vérifier l'évolution d'une réparation.

À propos de cet examen

Un **cystoscope** est un fin tube muni d'une caméra à son extrémité. Il en existe deux types :

- Le **cystoscope souple (flexible)** est généralement utilisé en consultation, sans anesthésie, avec un gel anesthésiant.
- Le **cystoscope rigide (droit)** est utilisé au bloc opératoire sous anesthésie et permet aussi de traiter un problème lors du même examen.

Un liquide stérile est introduit pour ouvrir doucement la vessie afin d'en voir clairement les parois. Votre chirurgien peut prescrire une cystoscopie pour :

- Rechercher la cause d'un **sang dans les urines** ou d'infections répétées
- Détecter un **rétrécissement (sténose)**, un calcul ou une tumeur
- Contrôler la cicatrisation d'une réparation ou prélever un petit échantillon (biopsie)
- Poser, contrôler ou retirer une **sonde (stent)** ou un fil de suture

Est-ce sans danger ?

Oui. La cystoscopie est l'un des examens urologiques les plus courants et présente peu de risques. La plupart des personnes ne ressentent qu'une gêne passagère. Les effets indésirables rares — une infection urinaire, un léger saignement ou des brûlures temporaires à la miction — sont en général bénins et disparaissent rapidement.

COMPRENDRE LES TERMES

Cystoscope

Fin tube optique muni d'une caméra et d'une lumière pour examiner l'intérieur de la vessie.

Vessie

Poche musculaire qui stocke l'urine jusqu'à la miction.

Urètre

Canal qui évacue l'urine hors du corps.

Souple vs rigide

Scope flexible (éveillé, en consultation) ou scope rigide (endormi, au bloc opératoire).

Gel anesthésiant

Anesthésique local placé dans l'urètre pour que le passage du scope soit confortable.

Biopsie

Petit prélèvement de tissu analysé au microscope.

Stent

Tube souple maintenant un conduit ouvert ; il peut être posé ou retiré lors de l'examen.

Résidu post-mictionnel

Quantité d'urine restant dans la vessie après la miction.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? Avec un scope souple, vous pouvez ressentir une brève pression ou un léger picotement lors de son passage — le gel anesthésiant atténue la sensation, et l'examen en consultation se termine généralement en quelques minutes. Avec un scope rigide, vous êtes endormi sous anesthésie et ne ressentez rien. Signalez immédiatement tout inconfort à l'équipe soignante.

Comment vous préparer (Avant l'examen)

- Pour une cystoscopie **en consultation (souple)**, vous pouvez généralement **manger, boire et prendre vos médicaments habituels**, et rentrer seul chez vous.
- Pour une cystoscopie **sous anesthésie**, suivez les instructions chirurgicales : jeûne, médicaments à suspendre, et prévoyez quelqu'un pour vous raccompagner.
- On peut vous demander un **échantillon d'urine** pour vérifier l'absence d'infection, et vous prescrire un **antibiotique**.

Informez votre équipe à l'avance si vous :

- Prenez un **anticoagulant**
- Avez des signes d'une **infection urinaire** (brûlures, fièvre, urines troubles ou malodorantes) — une infection active peut conduire à reporter l'examen
- Avez des allergies, ou un rétrécissement ayant rendu le passage d'un scope difficile par le passé

Déroulement de l'examen

- 1 Vous vous allongez confortablement et l'équipe vous aide à vous installer. L'orifice est nettoyé et le gel anesthésiant est appliqué.
- 2 Le cystoscope est introduit doucement dans l'urètre jusqu'à la vessie.
- 3 Un liquide stérile est injecté pour distendre la vessie ; votre chirurgien inspecte toute la paroi intérieure.
- 4 Le scope est retiré. Si un traitement, une biopsie ou un remplacement de stent est prévu, il est réalisé avant le retrait.

Après l'examen

- Après un examen en consultation, vous pouvez généralement reprendre vos **activités normales immédiatement** ; après une anesthésie, reposez-vous et prévoyez un accompagnateur.
- Vous pouvez ressentir de légères **brûlures à la miction** pendant un jour environ. Boire davantage d'eau aide à rincer et soulage.
- Vous pouvez observer une légère **teinte rosée** dans les urines pendant un court moment. C'est habituel et disparaît généralement en un jour.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- Des difficultés à uriner, ou une incapacité totale à uriner
- Un saignement abondant, ou des caillots de sang dans les urines
- Une douleur qui s'aggrave au lieu de s'améliorer

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La cystoscopie est un examen rapide et sûr qui permet d'explorer la vessie et l'urètre avec une fine caméra — elle aide votre chirurgien à identifier un problème ou à vérifier une réparation.
2. Peu de préparation est nécessaire pour un examen en consultation. Sous anesthésie, respectez le jeûne et prévoyez un accompagnateur. Signalez tout anticoagulant ou signe d'infection.
3. De légères brûlures ou une urine rosée pendant un jour sont normales — buvez davantage d'eau.